

Faculté de Médecine Université Constantine 3
Service de Médecine Interne- CHU Dr Benbadis Constantine
Module de sémiologie médicale
2024-2025

Dr. N. IDRI

La constipation





Objectifs pédagogique :

-  Définir une constipation
-  Savoir faire une démarche diagnostique d'une constipation
-  Reconnaître les étiologies de la constipation



Plan :

-  Définition
-  Physiopathologie
-  Etude sémiologique
-  Examens complémentaires
-  Etiologies



I. Définition :

- ❑ La constipation chronique est un syndrome très fréquent mais qui reste difficile à définir.
- ❑ Sur le plan clinique, la constipation se définit par un nombre de selles inférieur à 3 par semaine avec un poids moyen quotidien des selles inférieur à 35 g.

I. Définition :

Les critères de Rome IV consensuels plus moderne : au moins 2 des critères pendant au moins 3 mois :

- Moins de 3 selles spontanées par semaine
- Effort de poussée lors des défécations
- Selles dures (B1-B2 selon l'échelle de Bristol)
- Sensation d'évacuation rectale incomplète
- Manœuvres d'évacuations : utilisation d'une pression abdominale, une pression périnéale (masser autour de l'anus), appuyant sur la face postérieure du

Échelle de Bristol

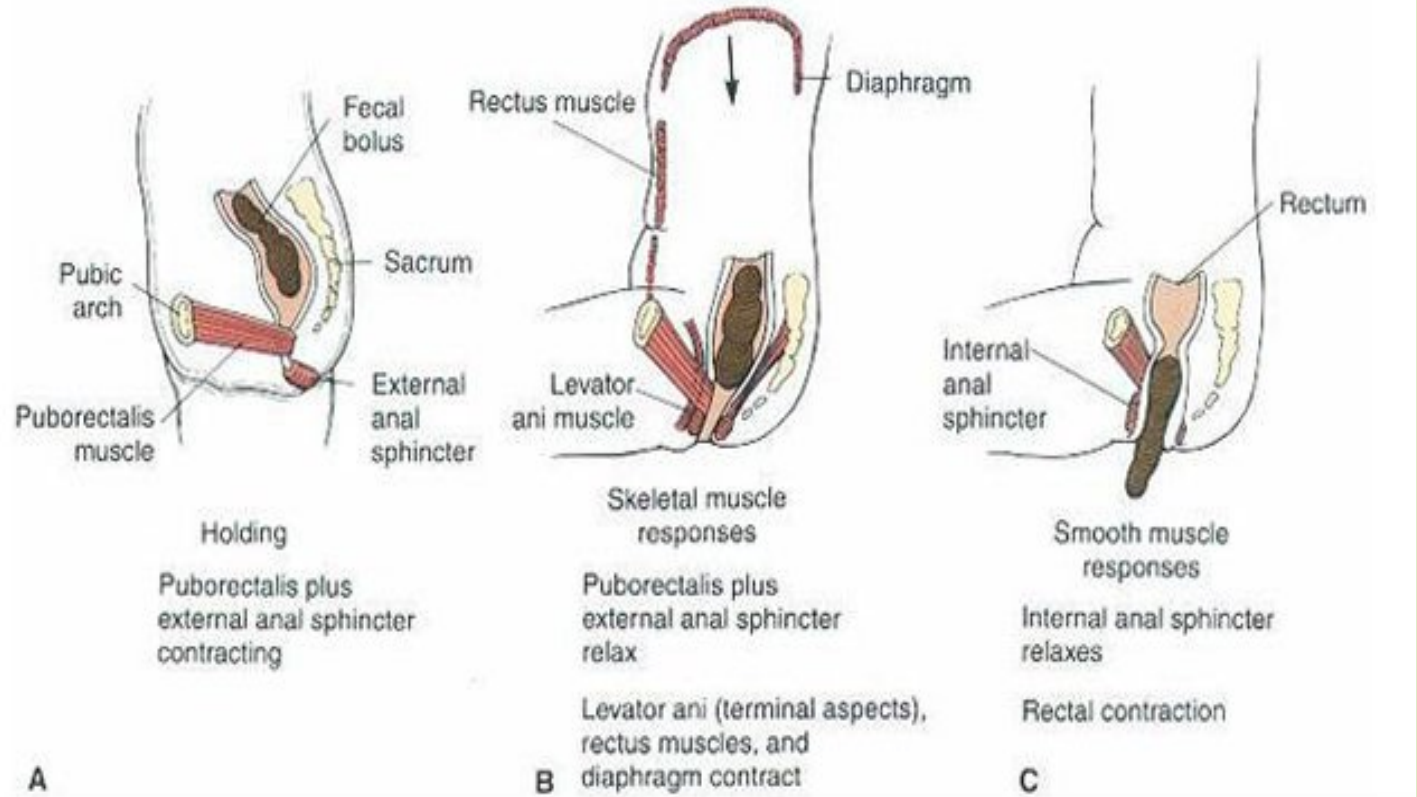
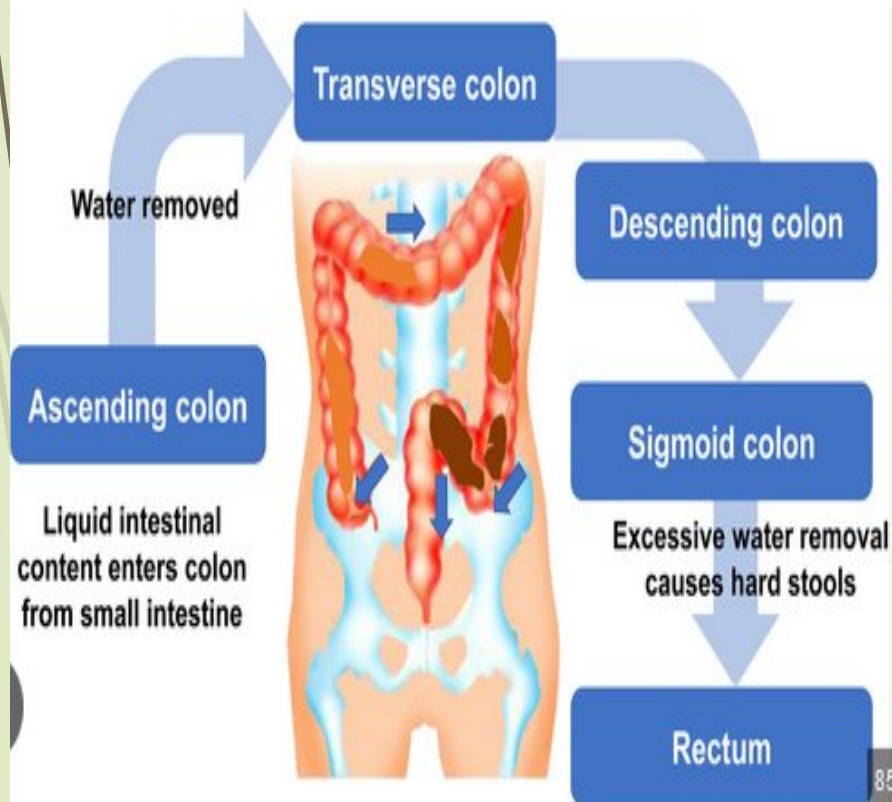
Type 1		Petites crottes dures et détachées, ressemblant à des noisettes. Difficiles à évacuer.
Type 2		En forme de saucisse, mais dures et grumeleuses.
Type 3		Comme une saucisse, mais avec des craquelures sur la surface. Crotte quasiment parfaite.
Type 4		Ressemble à une saucisse ou un serpent, lisse et douce. Crotte parfaite.
Type 5		Morceaux mous, avec des bords nets (néanmoins aisés à évacuer).
Type 6		Morceaux duveteux, en lambeaux, selles détrempées.
Type 7		Pas de morceau solide, entièrement liquide.

II. Physiopathologie :

 Une défécation normale se décompose en 3 temps :

- Stagnation des matières dans le sigmoïde
- Progression des selles du sigmoïde vers le rectum qui déclenche le réflexe recto-anal inhibiteur
- défécation par perception du besoin du canal anal, contraction des muscles de l'abdomen et une poussée des muscles releveurs de l'anus

II. Physiopathologie :



II. Physiopathologie :

 On distingue deux types de constipation :

1- Constipation maladie : la plus fréquente, souvent ancienne et isolée, deux mécanismes physiopathologiques prédominent mais peuvent être associés :

- Un trouble de la progression sur l'ensemble du côlon par inhibition de la motricité globale
- Un trouble de l'évacuation ou dyschésie.

2- Constipation symptôme : il s'agit souvent d'une constipation plus ou moins récente, secondaire, relevant ou accompagnant d'autres processus pathologiques.

III. Etude sémiologique :

A. L'interrogatoire :

- ❏ 1. Les antécédents personnels notamment chirurgicaux : chirurgie proctologique, urinaire, gynécologique, ou digestive
- ❏ 2. Le caractère de selles : fréquence, irrégularité des défécations, l'aspect des selles : volumineuses (bouchon), petites en forme de billes (on utilise l'échelle de Bristol pour aider le patient à décrire ses selles).
- ❏ 3. Le mode de début et évolution :
 - Récente et transitoire : à l'occasion d'un changement de rythme de vie ou professionnel
 - Récente et persistante : cause organique et en particulier un cancer colorectal
 - Ancienne et chronique, évoquant plutôt une cause motrice ou fonctionnelle.

III. Etude sémiologique :

A. L'interrogatoire :

- ❏ 4. Existence de manœuvres digitales pour faciliter l'exonération et la défécation, évocatrices d'une dyschésie anorectale (stagnation des matières fécales dans le sigmoïde par troubles de la l'évacuation).
- ❏ 5. existence de facteurs déclenchant : prise de nouveaux médicaments, modification des habitudes alimentaires avec diminution des apports hydriques et en fibres non digestibles, alitement.
- ❏ 6. Symptômes associés : douleurs abdominales, vomissements, météorisme, évacuation anormale : sang, glaire ; retentissement sur l'état général.
- ❏ 7. Traitement suivi notamment la nature des laxatifs utilisés.



III. Etude sémiologique :

B. L'examen physique :

- 1. L'examen abdominal : comporte l'inspection, la percussion et la palpation et l'auscultation : à la recherche d'une distension, un tympanisme, une hernie ou une éventration, une masse tumorale, une augmentation des bruits hydroaériques (obstacle).

III. Etude sémiologique :

B. L'examen physique :

2. L'examen de la région anorectale et périnéale est une étape importante :
- L'examen doit être fait en position accroupie lors de la poussée pour chercher un prolapsus rectal ou une ballonnisation périnéale.
 - L'examen en position genu-pectorale cherchera une lésion anale à type de fissure, hémorroïdes, tumeur ou abcès.



III. Etude sémiologique :

B. L'examen physique :

3. Le toucher rectal :

- Apprécie la tonicité du sphincter anal
- Recherche : une sténose anale ou rectale, une contracture paradoxale du sphincter anal (anismes), ampoule rectale vide, l'existence de matière chez un malade qui n'éprouve pas le besoin d'aller à la selle, ce qui permet d'évoquer le diagnostic de dyschésie rectale, un rectocèle.



III. Etude sémiologique :

B. L'examen physique :

-  4. Le toucher vaginal : chez la femme, recherche des lésions gynécologiques pouvant occasionner une constipation.
-  5. Le reste de l'examen physique doit être complet à la recherche d'une pathologie associée à l'origine de la constipation.



IV. Examens complémentaires :

A. Bilan initial :

❏ visant à éliminer une cause organique :

- Anuscopie, rectoscopie, coloscopie, coloscanner ou lavement baryté
- Un bilan biologique peut être demandé notamment le dosage des hormones thyroïdiennes si une hypothyroïdie est suspectée.

IV. Examens complémentaires :

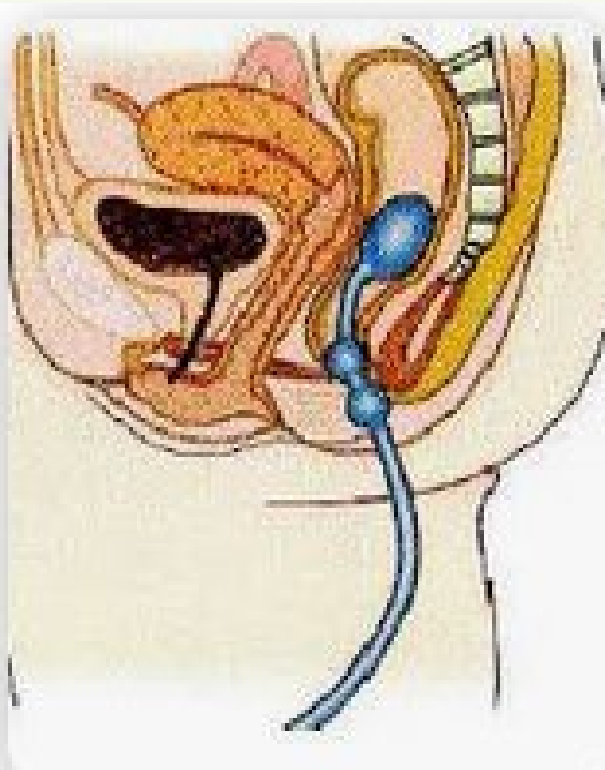
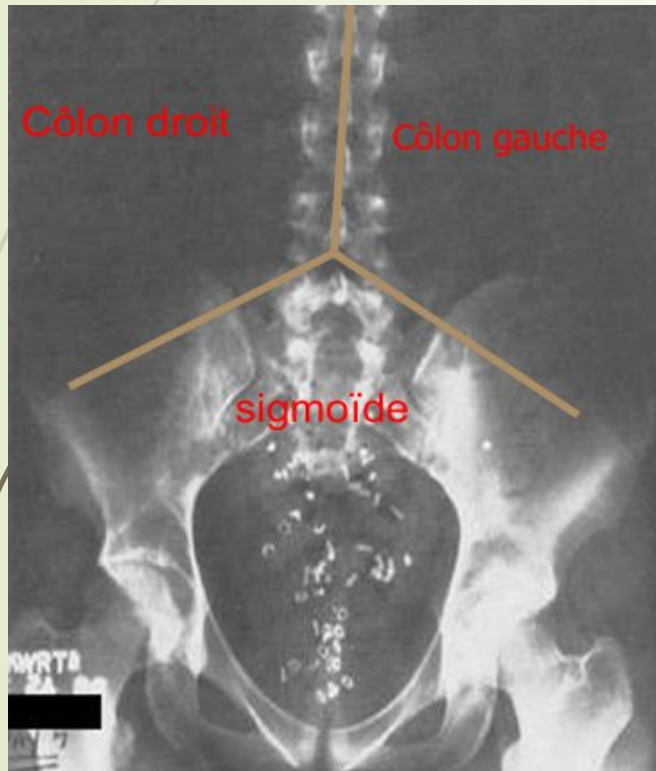
2. Bilan de 2^{ème} intention :

Il est demandé en fonction du contexte clinique, notamment si une constipation fonctionnelle est suspectée, il comprend essentiellement:

- la mesure du temps de transit colique
- une défécographie
- une manométrie anorectale.

IV. Examens complémentaires :

2. Bilan de 2^{ème} intention :



V. ETIOLOGIES :

A. Constipation organique :

-  1. Causes digestives : Cancer colorectal, tumeurs bénignes colorectales, sténoses coliques ou anorectale, mégacôlon congénital, fissure, séquelles de chirurgie anorectale, compressions extrinsèques.
-  2. Causes endocriniennes et métaboliques : hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, insuffisance rénale, hypokaliémie, porphyrie.
-  3. Causes neurologiques et constipation psychogène : dysautonomie au cours du diabète et de l'amylose, maladie de parkinson, sclérose en plaque, accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale, dépression, démence et psychose.
-  4. Médicaments : opiacés, anticholinergiques, anti convulsivants, neuroleptiques...

V. ETIOLOGIES :

B. Constipation maladie :

1. Par anomalie de progression :

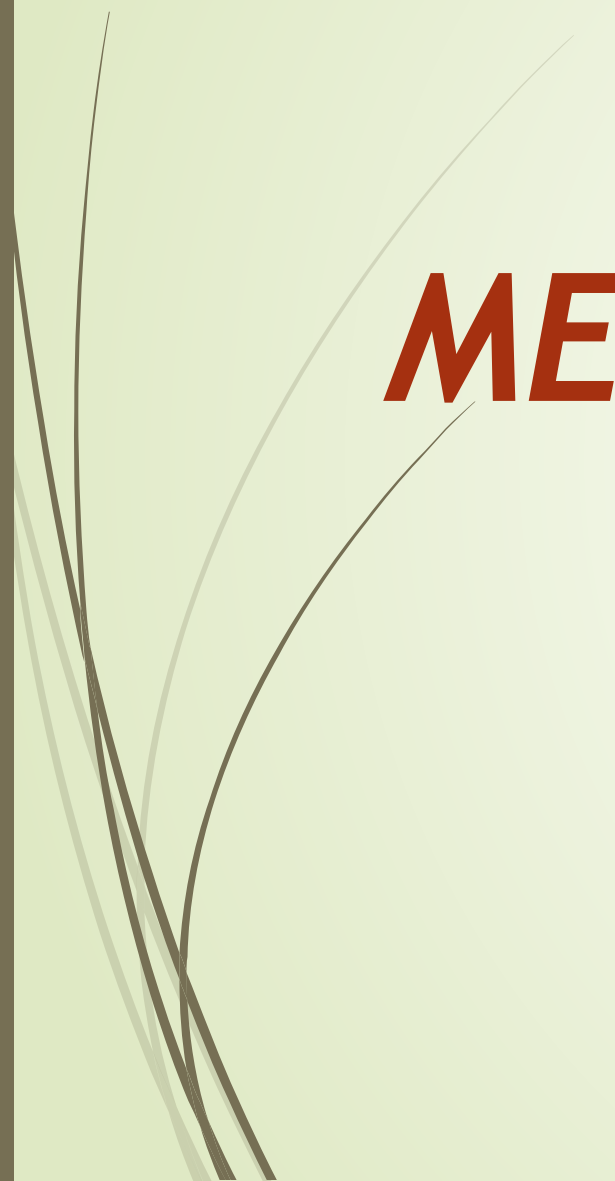
- Dans ce cas : souvent le nombre de selles < 3 par semaine, ballonnement abdominal, douleur abdominale, pas de besoin entre les exonérations, selles dures.
- Les causes : Inertie colique, colon spastique

2. Par anomalie d'évacuation :

- Souvent le besoin est présent, difficulté d'exonération, au TR : matières présentes, souvent utilisation de manœuvre digital pour évacuer.
- Les causes : anisme , méga rectum , rectocèle, procidence interne du rectum, anomalie de la sensibilité rectale, plancher pelvien descendant.

Référence :

- Evelyne Moulin, Pour en finir avec la constipation, e-book, Ed. Les Asclépiades, 2014
- Higgins PD, Johanson JF, Epidemiology of constipation in North America: a systematic review [archive], Am J Gastroenterol, 2004;99:750-9
- Brian E. Lacy, Fermín Mearin, Lin Chang et William D. Chey, « Bowel Disorders », *Gastroenterology*, série Rome IV - Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction, vol. 150, n° 6, 1^{er} mai 2016, p. 1393–1407.e5 ([DOI 10.1053/j.gastro.2016.02.031](https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.031), [lire en ligne](#))



***MERCI POUR VOTRE
ATTENTION***